

EXÁMEN RESIDENCIAS MÉDICAS

LLAMADO A EXAMEN ÚNICO PARA SELECCIÓN DE
RESIDENTES – 2018

Cuadernillo: MEDICINA BÁSICO - A

10) ¿Cuál de las siguientes patologías produce neumotórax espontáneo?

- A- Pancreatitis aguda.
 - B- Ruptura de bullas subpleurales.
 - C- Infarto pulmonar.
 - D- Traumatismo torácico.
-

11) ¿El sufijo “ostomía” qué significa?

- A- Extracción del órgano.
 - B- Punción del mismo.
 - C- Unión de dos órganos.
 - D- Abocamiento al exterior.
-

12) Ante una estructura radiológica dudosa a nivel del colon sigmoides alto, usted indica:

- A- Radioscopia.
 - B- Repetir RX.
 - C- Colonoscopia.
 - D- TAC.
-

13) Todas las siguientes lesiones son premalignas excepto:

- A- Poliposis juvenil
 - B- Adenoma vellosa.
 - C- Poliposis familiar.
 - D- Pseudopolipos en colitis ulcerosa.
-

14) ¿Cuál es el elemento más posterior del pedículo hepático?

- A- Colédoco.
 - B- Arteria hepática.
 - C- Vena porta.
 - D- Vena cava.
-

15) ¿Cuál es el orden de aparición de los síntomas en la apendicitis aguda (cronología de Murphy)?

- A- Fiebre, náuseas, epigastralgia.
 - B- Fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas.
 - C- Epigastralgia, náuseas, dolor en fosa ilíaca derecha.
 - D- Leucocitosis, fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha.
-

16) Ante una paciente de 40 años de edad que fue diagnosticada de pancreatitis aguda, a las 3 semanas de evolución de la enfermedad, encontrándose asintomática, la ecografía abdominal evidencia una colección delimitada, de 35mmx30mm, la cual tiene características de pseudoquiste pancreático. ¿Qué conducta tomaría?

- A- Intervención quirúrgica.
 - B- Drenaje percutáneo de la colección líquida.
 - C- Actitud expectante, por resolución espontánea.
 - D- Punción con aguja fina guiada por ecografía para toma de muestra.
-

17) En la hemorragia digestiva baja grave la causa etiológica más frecuente es:

- A- Diverticulosis.
 - B- Poliposis colónica.
 - C- Adenocarcinoma de colon.
 - D- Diverticulitis.
-

18) Las hemorroides internas que solo se objetivan por anoscopia. ¿A qué grado corresponden?

- A- 1.
 - B- 2.
 - C- 3.
 - D- 4.
-

19) ¿Cuál es el cáncer de tiroides más frecuente?

- A- Papilar.
 - B- Follicular.
 - C- Medular.
 - D- Anaplásico.
-

20) ¿Cuál de estas fracturas puede originar una pérdida sanguínea de 1500cc de sangre?

- A- Antebrazo.
 - B- Fémur.
 - C- Húmero.
 - D- Tibia.
-

21) ¿Cuál es el tipo histológico más común en el cáncer gástrico?

- A- Linfoma.
 - B- Adenocarcinoma.
 - C- Leiomioma.
 - D- Carcinoides.
-

22) El tratamiento quirúrgico del cáncer de colon derecho es:

- A- Hemicolectomía derecha.
 - B- Colectomía total.
 - C- Operación de Hartmann.
 - D- Cecostomía.
-

23) ¿Cuál es el síntoma más común en la fisura anal?

- A- Hemorragia.
 - B- Dolor.
 - C- Secreción purulenta.
 - D- Prurito.
-

24) El tumor maligno hepático más frecuente es:

- A- Angiosarcoma.
 - B- Colangiocarcinoma.
 - C- Tumor metastásico.
 - D- Carcinoma hepatocelular.
-

25) ¿Cuál es la localización más frecuente de tumores carcinoides?

- A- Aparato respiratorio.
 - B- Aparato urinario.
 - C- Aparato gastrointestinal.
 - D- Sistema nervioso central.
-

26) Una paciente de 78 años es traída por los familiares a la Guardia por hematemesis. Sólo refieren que padece artrosis, por lo que ingiere diclofenac. A la exploración física: PA 100/60 mmHg. Fc100/min., con palidez generalizada. ¿Cuál es la etiología más frecuente en este cuadro de hemorragia digestiva?

- A- Esofagitis erosiva.
 - B- Várices esofágicas.
 - C- Síndrome de Mallory Weiss.
 - D- Úlcera péptica.
-

27) Paciente de 25 años de edad, con antecedentes de asma intermitente leve, que presenta crisis de broncorreactividad con el ejercicio por lo que decide consultar. Ud. Indica:

- A- Evitar el ejercicio.
 - B- Corticoesteroides orales a bajas dosis en tratamiento continuo.
 - C- Agonistas beta2 de corta acción más antileucotrienos antes del ejercicio.
 - D- Agonistas beta2 de larga acción más teofilina.
-

28) Si se presenta a la consulta una paciente de 60 años de edad refiriendo debilidad muscular que empeora hacia el anochecer y mejora con el reposo, diplopía, disartria, voz nasal y disfonía, usted considera como diagnóstico más probable a:

- A- Meningitis.
 - B- Mielitis transversa.
 - C- Miastenia gravis.
 - D- Miositis.
-

29) El síndrome de Zollinger Ellison se caracteriza por:

- A- Hipersecreción de gastrina.
 - B- Hipersecreción de insulina.
 - C- Hiposecreción de somatostatina.
 - D- Hiposecreción de serotonina.
-

30) ¿Cuál es una manifestación clínica de la INSUFICIENCIA SUPRERRENAL PRIMARIA Crónica?

- A- Incremento del vello axilar y púbico en la mujer.
 - B- Aumento de peso con hiporexia.
 - C- Hiperpigmentación cutánea y mucosa.
 - D- Hipopigmentación de areolas mamarias.
-

31) Marque lo correcto con respecto a ascitis:

- A- La causa más frecuente de ascitis es la insuficiencia cardíaca descompensada.
 - B- EL mejor método complementario para confirmar o descartar ascitis es la radiografía directa de abdomen.
 - C- La paracentesis diagnóstica sólo está indicada en caso de ascitis con fiebre.
 - D- El gradiente albúmina del suero / albúmina de la ascitis (GASA) diferencia entre ascitis con o sin hipertensión portal.
-

32) ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis aséptica?

- A- Tuberculosis.
- B- Citomegalovirus.
- C- Enterovirus.
- D- Adenovirus.

33) La mayoría de los enfermos con glomerulopatía membranosa se presenta con:

- A- Hipertensión arterial.
 - B- Microhematuria.
 - C- Proteinuria selectiva subnefrótica.
 - D- Síndrome nefrótico.
-

34) ¿A qué síndrome neurológico corresponde la presencia de hipotonía, reflejos pendulares y dismetría?

- A- Síndrome piramidal.
 - B- Síndrome cerebeloso.
 - C- Síndrome extrapiramidal.
 - D- Polineuropatía.
-

35) La angina de pecho se diagnostica por:

- A- Ecocardiograma.
 - B- Electrocardiograma.
 - C- Prueba de esfuerzo.
 - D- La clínica.
-

36) En los pacientes con síndrome de Cushing, la causa de muerte más importante es:

- A- Enfermedad cardiovascular.
 - B- Infecciones bacterianas.
 - C- Suicidios.
 - D- Miopatía proximal.
-

37) ¿Cuál de los siguientes métodos diagnósticos es el gold standard para enfermedad celíaca?

- A- Biopsia gástrica.
 - B- Biopsia duodenal.
 - C- Anticuerpo antiendomio.
 - D- Anticuerpo antitransglutaminasa.
-

38) ¿Cuál es el tratamiento de elección en una fibrilación auricular aguda, con descompensación hemodinámica, sin cardiopatía estructural?

- A- Amiodarona.
 - B- Betabloqueantes.
 - C- Antiagregación.
 - D- Cardioversión eléctrica.
-

39) En el tratamiento del asma crónico parcialmente controlado Ud. Indica:

- A- Broncodilatadores.
 - B- Corticoides inhalados.
 - C- Antileucotrienos.
 - D- Broncodilatadores más corticoides inhalados.
-

40) El compromiso de dolor al movimiento en la columna vertebral que calma en reposo, asociado a dolor de articulaciones interfalángicas distales con rigidez matinal de menos de 1 hora de duración en una mujer de 60 años nos hace pensar, en primer lugar en:

- A- Artrosis primaria.
 - B- Artrosis secundaria.
 - C- Espondilitis anquilosante.
 - D- Espondilitis asociada a artropatía seronegativa.
-

41) Un paciente de 18 años de edad sin enfermedades constatadas ingresa a la guardia tras haber consumido 20 comprimidos de Carbamazepina de 200mg hace una hora atrás con fines autolíticos. Al examen se evidencia. TA 100/60mmHg FC 110 lpm, FR 25 rpm, T° 36,5°C. Presenta una mecánica ventilatoria regular, pupilas mióticas, hiporreactivas, estuporoso. Reacciona a estímulos fuertes. Ante este caso Ud. Lo primero que haría es:

- A- Tomar muestra de orina o sangre antes de comenzar con algún tratamiento.
- B- Coloca una sonda nasogástrica inmediatamente para intentar recuperar el fármaco ingerido.
- C- Infusión de carbón activado 1mg/kg por sonda nasogástrica para contrarrestar el fármaco.

D- Intubación orotraqueal para protección de la vía aérea.

42) Más del 90% de los pacientes con Lupus eritematoso sistémico presentan artritis. ¿Cuáles son las características de la misma?

- A- Artritis por depósito de microcristales.
- B- Mono artritis no erosiva de esqueleto axial.
- C- Artritis erosiva deformante.

D- Artritis no erosiva, simétrica, no deformante.

43) ¿Cuál es la complicación neurológica más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus?

- A- Parálisis facial periférica.
 - B- Neuralgia del trigémino.
 - C- Polineuropatía distal.**
 - D- Mononeuritis múltiple.
-

44) El síndrome piramidal cursa con el siguiente signo:

- A- Rigidez.
- B- Signo de la rueda dentada.
- C- Mioedema.

D- Clonus.

45) ¿Cuál de las siguientes entidades se asocia con alcalosis metabólica?

- A- Intoxicación con salicilatos.
- B- Insuficiencia renal aguda.
- C- Intoxicación alcohólica.

D- Uso de diuréticos de asa.

46) En el síndrome piramidal crónico se encuentra:

- A- Hipotonía muscular.
 - B- Hiperrreflexia.**
 - C- Hipoestesia.
 - D- Temblor intencional.
-

47) ¿Qué situación produce una anemia regenerativa?

- A- Invasión medular por leucemia.
- B- Deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12.
- C- Deficiencia de eritropoyetina.

D- Anemia hemolítica.

48) ¿Cuál es la enfermedad del tejido conectivo que se acompaña con mayor frecuencia de hipertensión pulmonar?

- A- Artritis reumatoidea.
- B- Lupus eritematoso sistémico.
- C- Esclerodermia.**
- D- Dermatomiositis.

49) Ante un adolescente que consulta por prurito intenso y molesto confinado al área genital. ¿cuál sería el origen más lógico de ese síntoma si no refiere ninguna otra molestia?

A- Escabiosis.

B- Pediculosis del pubis.

C- Infección por papiloma virus.

D- Molusco contagioso.

50) Una niña de 5 meses está internada en terapia intensiva por un cuadro de hipotonía grave, con asistencia respiratoria mecánica, la función hepática y renal están normales. En los días previos a la internación comió miel de abeja (los padres se la dieron por un cuadro de tos) y estuvo constipada. El esquema de vacunación estaba completo para su edad. ¿Cuál de las siguientes toxinas es más probable detectar en el laboratorio?

A- Toxina de Bordetella Pertussis.

B- Toxina botulínica.

C- Toxina tetánica.

D- Verotoxina.

51) Señale lo CORRECTO sobre sarampión en la edad pediátrica:

A- Las manchas de Koplik características de la enfermedad, se observan durante toda la fase prodrómica, que dura 3 a 5 días.

B- La gravedad de la enfermedad no guarda relación directa con la extensión y confluencia del exantema.

C- Las principales complicaciones del sarampión son la otitis, la neumonía y la encefalitis.

D- El recuento de leucocitos tiende a ser alto con neutrofilia franca.

52) Ud. Examina a un lactante de 2 meses de edad y detecta fimosis, al respecto les informa a los padres del niño:

A- Es una entidad poco frecuente a esta edad, debe ser estudiado.

B- Es un proceso fisiológico, no indica ningún tratamiento.

C- Si al cumplir un año de vida no se resuelve, requiere cirugía.

D- Debe comenzar tratamiento con crema de corticoides lo antes posible.

53) La realización de la pinza permite explorar:

A- Motricidad gruesa.

B- Conducta adaptativa.

C- Interacción con el medio.

D- Motricidad fina.

54) ¿Cuál es la talla media aproximada a los 4 años de edad?

A- 90cm.

B- 100cm.

C- 110cm.

D- 120cm.

55) Ante un lactante de 3 meses de edad, luce agitado y sudoroso en la frente al alimentarse y se ausculta un soplo continuo en maquinaria. El niño tiene:

A- Comunicación interauricular.

B- Comunicación interventricular.

C- Ductus arterioso permeable.

D- Hipertensión pulmonar.

56) Señale cuál de las siguientes es la complicación más frecuente del resfrío común en lactantes:

- A- Laringitis.
 - B- Otitis media.
 - C- Sinusitis.
 - D- Neumonía.
-

57) Un niño de 20 meses de edad que presenta leucocoria en el ojo derecho. ¿Qué enfermedad entre las enumeradas puede padecer?

- A- Dacriocistitis.
 - B- Coloboma del iris.
 - C- Glaucoma.
 - D- Retinoblastoma.
-

58) En relación con la hipopotasemia, señalar lo correcto:

- A- El corazón y el músculo esquelético son muy vulnerables a la hipopotasemia.
 - B- Los cambios electrocardiográficos incluyen ondas T picudas.
 - C- Las manifestaciones más frecuentes son tetania y laringoespasma.
 - D- La hipopotasemia acelera la motilidad intestinal.
-

59) Marcar la respuesta correcta relacionada con la Ascaridiasis:

- A- Los problemas clínicos más frecuentes se deben a la enfermedad pulmonar y a la obstrucción intestinal.
 - B- El compromiso intestinal por el parásito adulto se manifiesta como síndrome de malabsorción.
 - C- El diagnóstico de certeza se realiza por ecografía.
 - D- Las condiciones socioambientales no influyen en la transmisión de la enfermedad.
-

60) ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas contraindica la maniobra para investigar el reflejo óculo cefálico o en "ojos de muñeca"?

- A- Signos de hipertensión endocraneana.
 - B- Signos de shock.
 - C- Sospecha de lesión de la columna cervical.
 - D- Anisocoria.
-

61) Un niño que recibe alimentación con pecho materno exclusivo debe incorporar alimentos semisólidos a la edad de:

- A- 4 meses.
 - B- 6 meses.
 - C- 9 meses.
 - D- 12 meses.
-

62) ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye una contraindicación absoluta para la lactancia materna?

- A- Reanudación de la menstruación de la madre.
 - B- Una nueva gestación de la madre.
 - C- Madre con hepatitis B, ya adquirida.
 - D- Madre con tuberculosis activa.
-

63) Paciente de dos años que ingresa con petequias generalizadas, gingivorragia y epistaxis de 2 días previos, con infección respiratoria hace 15 días. Hemograma: Hemoglobina 12 gs/dl; G. Blancos 6500 mm³ (fórmula normal); Plaquetas 9000 mm³. Buen estado general, signos vitales normales. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

- A- Púrpura de Schonlein Henoch.
- B- Leucemia linfoblástica aguda.
- C- Meningococcemia.
- D- Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI).

64) En un paciente de 8 años, previamente sano, que presenta dolor abdominal difuso y artralgias con tumefacción articular y cuadro purpúrico (púrpura palpable) limitado a extremidades inferiores que evoluciona por brotes debe hacer pensar, como diagnóstico más probable, en:

- A- Vasculitis por lupus.
 - B- Enfermedad de Kawasaki.
 - C- Púrpura Trombótica Trombocitopénica.
 - D- Púrpura tipo Schonlein Henoch.
-

65) Juan Ignacio cumplió 11 años el 5 de enero y concurre para realizar la ficha médica escolar. ¿Qué vacuna le corresponde aplicarse según las normas vigentes?

- A- Anti Papiloma Virus Humano.
 - B- Antigripal.
 - C- Doble adulto acelular.
 - D- Sabin oral.
-

66) Ante un niño con sospecha de osteomielitis, ¿cuál es el estudio de imágenes que puede confirmar el diagnóstico dentro de las primeras 24-48hs?

- A- Rx simple, frente y perfil.
 - B- Ecografía.
 - C- TAC.
 - D- Resonancia Nuclear Magnética.
-

67) Un lactante de 1 mes de vida presenta ictericia colestásica desde el nacimiento, tiene deposiciones blancas y el hígado y el bazo agrandados. La fascie y el examen ocular son normales. ¿Cuáles de las siguientes opciones sería la causa más probable de la ictericia?

- A- Hepatitis autoinmune.
 - B- Incompatibilidad Rh.
 - C- Incompatibilidad ABO.
 - D- Atresia de vías biliares.
-

68) La mayoría de los niños comienzan a caminar de manera independiente a la edad de:

- A- Entre los 12 y 15 meses.
 - B- Entre los 8 y 10 meses.
 - C- Entre los 15 y 18 meses.
 - D- Entre los 18 y 20 meses.
-

69) Un niño de dos años ingirió accidentalmente una pila alcalina, tipo botón, hace una hora y por estudio radiográfico se encuentra ubicada en una de las estrecheces fisiológicas del esófago. Usted considera que la conducta terapéutica es:

- A- Ninguna, ya que no considera que se trate de una situación de riesgo para el paciente.
 - B- Indica extracción endoscópica inmediata.
 - C- Seguimiento radiológico hasta su eliminación.
 - D- Medica con proquinéticos para estimular la contractilidad esofágica y favorecer el pasaje de la pila al estómago.
-

70) En niños, la causa principal de hipertensión arterial secundaria es:

- A- Disautonomía.
 - B- Hipertensión nefrovascular.
 - C- Endocrinopatías.
 - D- Drogas o toxinas.
-

71) ¿En qué casos debe diferirse la vacunación antirrubéolica?

- A- Si se utilizó gamma globulina hace 6 meses previos.
 - B- En asmáticos tratados con dosis altas de corticoides durante 10 días.
 - C- Si se planea embarazo dentro de los próximos 30 días.
 - D- En el personal que trabaja en contacto íntimo con inmunodeprimidos.
-

72) Un niño con diarrea, que presenta: pulso normal, mucosas semi-húmedas, sediento, con un examen físico normal, tiene:

- A- Deshidratación Grave.
 - B- Deshidratación Moderada.
 - C- Deshidratación Leve.
 - D- No está deshidratado.
-

73) ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos produce el síndrome de Mondor?

- A- Peptoestreptococo.
 - B- Pseudomona aeruginosa.
 - C- Clostridium weichii.
 - D- Clostridium tetani.
-

74) ¿Cuál de los siguientes métodos permite hacer el diagnóstico de embarazo más precozmente?

- A- El tacto vaginal.
 - B- La determinación de gonadotropina coriónica en sangre.
 - C- La ecografía transvaginal.
 - D- La radiografía.
-

75) Una embarazada de 36 semanas, se presenta con pérdida de líquido claro por vagina. Ella está febril, 37,9 grados. La palpación del abdomen es dolorosa, hay leucocitosis con 16.000 blancos y taquicardia fetal. ¿Cuál es la conducta?

- A- Antibióticos, reposos y expectación.
 - B- Madurar con corticoides e inducir luego de 3 días.
 - C- Antibióticos y Cesárea de urgencia.
 - D- Antibióticos según protocolo para de profilaxis para estreptococo, e inducir el parto de inmediato según condiciones obstétricas y fetales.
-

76) Una paciente de 22 años se presenta a la guardia con una amenorrea de 9 semanas, un test de embarazo positivo, náuseas y vómitos, y en la ecografía se observa la cavidad uterina distendida a expensas de una imagen vacuolada en copos de nieve o racimo de uva, no visualizándose embrión. El diagnóstico más probable es:

- A- Hiperplasia endometrial glándulo-quística.
 - B- Aborto incompleto.
 - C- Mola parcial.
 - D- Mola hidatiforme.
-

77) Se cita como causa probable de hidramnios. (Poli-hidramnios):

- A- Anomalía fetal ligada al cromosoma X.
 - B- Malformaciones del tubo neural y del aparato digestivo.
 - C- Agenesia de miembros inferiores.
 - D- Sufrimiento fetal.
-

78) ¿Cuál es la causa más frecuente de cáncer de cuello uterino?

- A- Alcoholismo.
- B- Multiparidad.
- C- Virus papiloma humano.
- D- Tabaquismo.

79) ¿Cuál es la fecha probable de parto, si la paciente presentó como Fecha de última menstruación el 5 de agosto?

- A- 5 de junio.
 - B- 10 de junio.
 - C- 15 de mayo.
 - D- 20 de mayo.
-

80) En mujeres embarazadas Rh(-), la gammaglobulina híper inmune, debe ser prescrita en:

- A- Toda Rh(-) no isoinmunizada, a las 28 semanas y antes de las 72h horas después del parto siempre que el hijo sea Rh(+) y la reacción de Coombs sea negativa.
 - B- En todos los casos en que la madre sea Rh(+) no isoinmunizada y el hijo sea Rh(+).
 - C- En madres Rh(-) isoinmunizadas, en el último trimestre.
 - D- En toda Rh(-) no isoinmunizada con hijo Rh(+) antes de las 72 horas del parto, siempre que la reacción de Coombs indirecta sea positiva.
-

81) Paciente de 70 años de edad con tumor palpable en cuadrante supero externo de mama derecha, asociado en la mamografía a imagen de bordes espiculados y microcalcificaciones. Ud. Debería pensar en:

- A- Fibroadenoma de mama.
 - B- Enfermedad de Paget.
 - C- Displasia mamaria severa.
 - D- Cáncer de mama.
-

82) El tratamiento de elección para toxoplasmosis durante el embarazo es:

- A- Metronidazol.
 - B- Miconazol.
 - C- Tobramicina.
 - D- Espiromicina.
-

83) Para el screening de cáncer de mama, la conducta adecuada sería la siguiente:

- A- Mamografía bilateral y palpación anual, en pacientes de bajo riesgo, a partir de los 40 años.
 - B- Mamografía bilateral cada dos años, y repetir al año, solo las mamografías clasificadas como bi rads III.
 - C- Punción biopsia de los tumores palpables, no importando la edad de la paciente.
 - D- Mamoresonancia anual, desde los 40 a los 60 años.
-

84) ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuentemente involucrado en la infección urinaria durante el embarazo?

- A- Staphylococo aureus.
 - B- Proteus mirabilis.
 - C- Escherichia coli.
 - D- Klebsiella pneumoniae.
-

85) ¿Cuál de las siguientes presentaciones cefálicas es imposible finalizar por vía vaginal?

- A- Vértice u occipucio.
 - B- Cara.
 - C- Bregma.
 - D- Frente.
-

86) De todas las masas anexiales malignas diagnosticadas durante el embarazo, la más frecuente es:

- A- Disgerminoma.
- B- Cistoadenocarcinoma seroso.
- C- Cistoadenocarcinoma mucinoso.
- D- Tumor de células granulosas.

87) ¿Cuál es el cáncer de mama más frecuente?

- A- Carcinoma lobulillar.
 - B- Enfermedad de Paget.
 - C- Carcinoma ductal.
 - D- Carcinoma de células claras.
-

88) ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los anticonceptivos orales?

- A- Anovulación.
 - B- Cambios del moco cervical.
 - C- Endometritis química.
 - D- Alcalinización vaginal.
-

89) En cuanto a endometriosis:

- A- La laparoscopia es imprescindible para su diagnóstico.
 - B- La RMN (resonancia magnética nuclear) es el gold estándar para el diagnóstico.
 - C- Mujeres jóvenes en edad reproductiva no requieren tratamiento.
 - D- El danazol es el tratamiento de elección por sus bajos efectos adversos.
-

90) La arteria ovárica se origina en:

- A- Hipogástrica.
 - B- Aorta.
 - C- Uterina.
 - D- Ilíaca interna.
-

91) ¿Cuáles son los serotipos del virus del HPV más frecuentemente involucrados en la génesis del cáncer cervical?

- A- 6 y 11.
 - B- 16 y 18.
 - C- 51 y 54.
 - D- 35 y 45.
-

92) ¿Mediante ecografía transvaginal, a qué edad gestacional se puede objetivar por primera vez la presencia de latidos cardíacos fetales?

- A- 4 semanas.
 - B- 10 semanas.
 - C- 6 semanas.
 - D- 8 semanas.
-

93) Paciente de 25 años que presenta embarazo de 38 semanas, concurre a la consulta por dolor tipo cólico abdominal. AL examen constata contracciones uterinas, frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto, al tacto vaginal se constata cuello borrado centrado. 4cm de dilatación. Ud. Hace diagnóstico de:

- A- Amenaza de parto prematuro.
 - B- Cólico intestinal.
 - C- Trabajo de parto.
 - D- Infección urinaria.
-

94) El síntoma más común del cáncer de endometrio es:

- A- Amenorrea.
 - B- Secreción purulenta.
 - C- Dolor en hipogastrio.
 - D- Metrorragia.
-

95) Paciente cursando embarazo de 8 semanas consulta por genitorragia escasa, roja, a la especuloscopia se objetiva cuello sano, cerrado. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

- A- Aborto incompleto.
 - B- Amenaza de aborto.
 - C- Aborto completo.
 - D- Aborto séptico.
-

96) ¿Cuál de las siguientes es rama de la hipogástrica?

- A- Ovárica.
 - B- Hemorroidal inferior.
 - C- Pudenda.
 - D- Sacra media.
-

97) ¿Cuándo el profesional de la salud puede actuar sin el consentimiento informado del paciente?

- A- Cuando mediare grave peligro para la salud pública.
 - B- Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente puede prestar su consentimiento por sí mismo.
 - C- Cuando el paciente se encuentra en una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente no puede expresar su consentimiento, pero si puede hacerlo un pariente.
 - D- Cuando el paciente se encuentra con la posibilidad de poder rechazar el tratamiento indicado.
-

98) Como profesional de la salud, si el paciente le solicita la historia clínica, Ud. Debe:

- A- Entregar copia de la misma sin autenticar por autoridad competente de la institución asistencial.
 - B- Entregar copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial.
 - C- Entregar copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de emergencia.
 - D- Entregar copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las tres (12) horas de solicitada, salvo caso de emergencia.
-

99) Ud. Siendo profesional de la salud ¿Quién tiene permitido solicitarle una historia clínica?

- A- El paciente y su representante legal.
 - B- El paciente y su representante legal, cónyuge o persona que conviva con el paciente, los médicos y otros profesionales del arte de curar.
 - C- Solo otro médico.
 - D- Solo el cónyuge.
-

100) Se entiende por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:

- A- Su estado de salud.
- B- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos.
- C- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles.
- D- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.